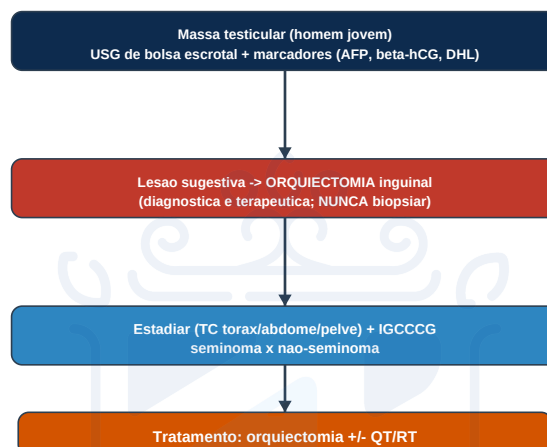


NEOPLASIA DE TESTÍCULO — MASSA NO JOVEM

FLUXOGRAMA — MASSA TESTICULAR

TESTÍCULO — USG -> ORQUIECTOMIA (NÃO BIOPSIAR)



EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

O QUE É

- Neoplasia sólida mais comum do HOMEM JOVEM (15-35 anos); altas taxas de cura (~95%; 80-90% mesmo com metástase)
- Tipo mais comum: tumor de CÉLULAS GERMINATIVAS (95%) — seminoma x não-seminoma
- Não-seminomas (mais agressivos): carcinoma embrionário, coriocarcinoma, tumor do seio endodérmico, teratoma; mistos comportam-se como não-seminoma
- Fatores de risco: história FAMILIAR (irmãos: risco 8-10x), CRIPTORQUIDIA (sobretudo correção tardia, > 13 anos)

QUADRO CLÍNICO

QUANDO SUSPEITAR

- MASSA testicular indolor (sintoma de maior destaque)
- Dor lombar (linfonodos retroperitoneais); sintomas de metástase (pulmão, SNC)
- Ginecomastia (mais no tumor de Leydig, mas possível nos germinativos por hCG)
- Síndromes paraneoplásicas: hipertireoidismo (hCG estimula a tireoide), encefalite límbica (anti-Ma2)
- Infertilidade pode preceder a massa palpável

EXAMES E MARCADORES

INVESTIGAÇÃO

- USG de bolsa escrotal = exame INICIAL (massa hipoeoica, calcificação, margens irregulares)
- NUNCA biopsiar (risco de contaminação do escroto/drenagem linfática) — a orquiectomia é diagnóstica
- Marcadores: AFP e beta-hCG (elevam nos NÃO-seminomas; no seminoma só beta-hCG em ~20%, AFP NÃO eleva); DHL avalia extensão
- Estadiamento: TC de tórax, abdome e pelve (metástases: pulmão, ossos, fígado, SNC)
- RM de crânio se sintomas ou risco desfavorável (metástase cerebral é quase exclusiva de não-seminoma)

SEMINOMA x NÃO-SEMINOMA

Aspecto	Seminoma	Não-seminoma
AFP	NÃO se eleva	Pode elevar
Beta-hCG	Eleva em ~20%	Pode elevar
Agressividade	Menos agressivo	Mais agressivo
Metástase SNC	Rara	Quase exclusiva deste grupo

TRATAMENTO

Rx ORQUIECTOMIA + QT/RT

ORQUIECTOMIA radical inguinal: base diagnóstica e terapêutica; marcadores pós-orquiectomia compõem o estadiamento
Estágio 1 (maioria): a cirurgia pode ser suficiente para a cura ($\pm$ vigilância/QT adjuvante conforme risco)
QT adjuvante: carboplatina (seminoma) ou BEP (Bleomicina + Etoposídeo + cisPlatina)
Bleomicina contraindicada se carga tabágica alta, disfunção renal ou idade > 50 -> substituir por ifosfamida
RT: para linfonodos retroperitoneais em casos selecionados (aumenta 2-6x o risco de 2a neoplasia em 10-16 anos)
Alternativa à RT em metástase linfonodal: linfadenectomia retroperitoneal

RED FLAGS / PONTOS-CHAVE

NÃO ERRAR

- NUNCA realizar biópsia transescrotal (dissemina; a via é inguinal com orquiectomia)
- Marcadores normais NÃO excluem o tumor (sobretudo seminoma)
- Toda massa testicular sólida no jovem = neoplasia até prova em contrário (USG + orquiectomia)
- Estratificar pelo IGCCCG (marcadores + extensão) para definir tratamento e prognóstico
- Discutir CRIOPRESERVAÇÃO de sêmen antes da QT/RT (fertilidade)

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Homem ____ anos com massa testicular ____ (USG: ____); marcadores AFP ____, beta-hCG ____, DHL ____.
- Fatores de risco: criptorquidia/história familiar; sintomas de metástase: ____.
- Conduta: encaminhamento para ORQUIECTOMIA inguinal (não biopsiar) + estadiamento (TC).
- Encaminhamento à urologia/oncologia; oferecer criopreservação de sêmen.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Homem de 25 anos com massa testicular sólida indolor à USG. Qual a conduta diagnóstica correta?

- A) Biópsia transescrotal da massa
- B) Orquiectomia radical inguinal (diagnóstica e terapêutica) — não se biopsia o testículo
- C) Punção aspirativa escrotal
- D) Apenas observação
- E) Antibiótico para orquite

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Sobre os marcadores tumorais no câncer de testículo, é correto:

- A) A AFP se eleva no seminoma puro
- B) AFP e beta-hCG elevam-se nos não-seminomas; no seminoma a AFP não se eleva e o beta-hCG sobe em ~20%
- C) Marcadores normais excluem o diagnóstico
- D) O PSA é o principal marcador
- E) A DHL não tem utilidade

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o exame inicial de escolha na suspeita de neoplasia testicular?

- A) Tomografia de pelve
- B) Ultrassonografia da bolsa escrotal
- C) Ressonância de crânio
- D) Cintilografia
- E) PET-CT

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual fármaco quimioterápico do esquema do câncer de testículo é contraindicado em tabagistas pesados, disfunção renal ou idade > 50 anos?

- A) Cisplatina
- B) Bleomicina (substituir por ifosfamida)
- C) Etoposídeo
- D) Carboplatina
- E) Ifosfamida

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual fator de risco está classicamente associado ao câncer de testículo?

- A) Tabagismo
- B) Criptorquidia (sobretudo com correção tardia)
- C) Obesidade
- D) Vasectomia
- E) Hipertensão

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Massa testicular sólida no jovem é neoplasia até prova em contrário: a conduta é orquiectomia radical por via INGUINAL (diagnóstica e terapêutica). NUNCA se biopsia o testículo por via transescrotal (risco de disseminação).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

AFP e beta-hCG elevam-se nos não-seminomas; no seminoma puro a AFP NÃO se eleva e o beta-hCG sobe em ~20%. A DHL avalia extensão. Marcadores normais não excluem o tumor.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A USG da bolsa escrotal é o exame inicial de escolha, caracterizando a massa (hipoecoica, com calcificações/margens irregulares) e indicando a orquiectomia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A bleomicina (do esquema BEP) é contraindicada em tabagistas pesados, disfunção renal e idade > 50 anos pelo risco de toxicidade pulmonar — substitui-se por ifosfamida.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A criptorquidia, especialmente com correção tardia (> 13 anos), é fator de risco clássico, assim como a história familiar (irmãos com risco 8-10x maior).

SM24
Suporte ao Plantão Médico